HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 1

Conceitos fundamentais e princípios gerais

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 1

MÓDULO	1 de 5, ao vivo, em 2 partes
CARGA	6 horas (2 partes de 3h)
DOCUMENTO BASE	RDC 751/2022; Regulamento (UE) 2017/745; 21 CFR 807 e 814; ISO 14155:2026; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das duas partes do Módulo 1, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia a evidência clínica de um dispositivo.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	Classificação de risco: por que e como	4
2	As quatro classes nas três jurisdições	7
3	Os caminhos de regularização	10
4	Avaliação clínica e investigação clínica	13
5	O dossiê técnico visto por quem avalia	16
6	Uso pretendido e mau uso	19
7	Harmonização e caso integrador	22
8	Glossário	25
9	Para revisar	26

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 1 tem duas partes ao vivo e seis blocos. A Parte 1 cobre classificação de risco e regimes; a Parte 2 cobre avaliação clínica, dossiê técnico, uso pretendido e harmonização.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Classificação de risco: critérios, regras e as quatro classes	Parte 1, slides 4 a 18	Capítulos 1 e 2	Perguntas 1 e 2
2	Regimes regulatórios no Brasil, nos EUA e na UE	Parte 1, slides 19 a 26	Capítulo 3	Pergunta 3
3	Avaliação clínica e investigação clínica	Parte 2, slides 4 a 12	Capítulo 4	Perguntas 4 e 5
4	Dossiê técnico	Parte 2, slides 13 a 18	Capítulo 5	Pergunta 6
5	Uso pretendido e mau uso	Parte 2, slides 19 a 26	Capítulo 6	Pergunta 7
6	Harmonização e caso integrador	Parte 2, slides 27 a 33	Capítulo 7	Pergunta 8

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com o documento oficial aberto pelo link da fonte.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Siga a faixa Na aula e anote os exemplos e as dúvidas na página de anotações.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda às perguntas de Para revisar ligadas ao capítulo e complete as suas anotações.

ANTES DO MÓDULO 2

O Módulo 2 entra no processo de avaliação clínica e na condução da investigação: ética, papéis, documentos e estratégia de evidência. Chegue com a diferença entre avaliação e investigação clara (Capítulo 4).

CAPÍTULO 1

Classificação de risco: por que e como

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 7** Para revisar • Pergunta 1

Repare como cada critério de classificação muda o volume de evidência clínica que o avaliador vai cobrar.

Antes de falar em avaliação clínica, você precisa saber em que classe de risco o dispositivo está. É a classe que diz quanto de evidência o avaliador vai exigir e por qual caminho regulatório o produto passa.

Pense na classificação como a primeira pergunta de qualquer revisão técnica. Se ela estiver errada, todo o resto fica desalinhado: o regime escolhido, a profundidade da avaliação clínica, a necessidade de investigação própria e até o tempo e o custo do projeto. Por isso, quem revisa um dossiê começa conferindo a classe e a regra que a sustenta.

O modelo de regras que o Brasil e a União Europeia usam tem a mesma origem: foi desenvolvido no GHTF e hoje é mantido pelo IMDRF. No Brasil, a classificação está na RDC 751/2022, que entrou em vigor em 1º de março de 2023 e traz as regras no Anexo I. Na União Europeia, as regras estão no Anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745.

Os critérios que movem a classe

- **Duração do contato**. Transitório (menos de 60 minutos), curto prazo (de 60 minutos a 30 dias) ou longo prazo (mais de 30 dias). Quanto mais tempo no corpo, maior tende a ser a classe.
- **Invasividade**. Não invasivo, invasivo por orifício do corpo, cirurgicamente invasivo ou implantável.
- **Local anatômico**. Contato com coração, sistema circulatório central ou sistema nervoso central eleva a classe.
- **Energia**. Dispositivos ativos têm regras próprias, ligadas ao que fornecem ou controlam no paciente.

> **COMO O AVALIADOR CONFERE**
>
> Ele aplica todas as regras que podem se encaixar no produto e fica com a classe mais alta. Depois verifica se o fabricante registrou a regra escolhida e o motivo de ter descartado as outras. Uma classe sem regra citada é um ponto fraco imediato.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Classificação de risco: por que e como

As quatro classes

No Brasil, as classes vão de I (baixo risco) a IV (máximo risco). As classes I e II seguem a regularização por notificação e as classes III e IV, a regularização por registro, conforme os artigos 6º e 7º da RDC 751/2022. Você vai ver no capítulo 3 o que muda em cada caminho de regularização.

IDEIA-CHAVE

A classe decide o caminho e a evidência. Classificar com a regra certa, e com a justificativa escrita, é o que torna o restante do dossiê defensável.

Fonte: RDC 751/2022, art. 5º a 7º e Anexo I; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII; IMDRF, documentos de classificação.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Classificação de risco: por que e como

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

As quatro classes nas três jurisdições

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 8 a 18** Para revisar • Pergunta 2

Compare, para cada classe, o que muda no Brasil, nos EUA e na União Europeia e onde a evidência clínica passa a pesar.

A mesma lógica de risco aparece nas três jurisdições, mas os nomes, as vias e as exigências não são idênticos. Para quem avalia, o ponto é entender em que momento a evidência clínica deixa de ser um apoio e passa a ser decisiva.

Classes I e II: risco baixo e médio

Na Classe I estão, em geral, dispositivos não invasivos ou de contato transitório, como um estetoscópio ou uma cadeira de rodas. O foco do controle fica em boas práticas de fabricação, rotulagem e instruções de uso. A evidência clínica costuma vir da documentação técnica e da literatura de uma tecnologia consolidada.

Na Classe II entram, por exemplo, invasivos de curta duração e equipamentos de diagnóstico cujos riscos são controláveis. Atenção às regras que puxam a classe para cima: uma bomba de infusão de medicamentos potencialmente perigosos sobe para a Classe III pela Regra 12, e um monitor de parâmetros vitais cuja variação gera perigo imediato também vai para a Classe III pela Regra 10.

JURISDIÇÃO	CLASSE I	CLASSE II
Brasil	Notificação, sem análise técnica prévia	Notificação, com declaração de atendimento à RDC 665/2022
EUA	Maioria isenta de 510(k), com controles gerais	Na maioria, 510(k): equivalência substancial a um predicado
União Europeia	Autodeclaração do fabricante; organismo notificado só nos aspectos estéril, de medição ou reutilizável	Classe IIa e IIb com participação de organismo notificado

Classes III e IV: alto e máximo risco

Aqui estão os implantáveis de longo prazo, os dispositivos em contato com coração, sistema circulatório central ou sistema nervoso central, as próteses articulares e os implantáveis ativos. A falha pode causar dano grave ou fatal. No Brasil, essas classes exigem certificado de boas práticas de fabricação e análise técnica pela Anvisa. Nos EUA, a Classe III segue em geral a via PMA. Na União Europeia, implantáveis e Classe III exigem investigação clínica, salvo as exceções previstas no artigo 61(4) a (6) do MDR.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

As quatro classes nas três jurisdições

ERRO COMUM

Tratar dois produtos da mesma classe como se exigissem a mesma evidência. Um importador de um stent já estudado no exterior e uma startup com um stent inovador estão na mesma classe, mas o segundo não tem equivalente e precisa de investigação clínica própria. São exemplos ilustrativos, usados na aula para comparar caminhos.

IDEIA-CHAVE

Quanto mais alta a classe, mais provável que a literatura não baste e que a investigação clínica própria entre no caminho.

Fonte: RDC 751/2022, Anexo I, Regras 1, 8, 10, 12 e 14; 21 CFR 807; 21 CFR 814; Regulamento (UE) 2017/745, art. 52 e 61.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

As quatro classes nas três jurisdições

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Os caminhos de regularização

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 19 a 26** Para revisar • Pergunta 3

Observe a diferença entre o que a Anvisa analisa antes da decisão e o que fica sob responsabilidade da empresa.

Definida a classe, o próximo passo é o caminho de regularização. Entender o que cada regime pede ajuda você a prever quanto de evidência clínica será lido por alguém antes da decisão.

Brasil: notificação e registro

A RDC 751/2022 prevê dois regimes de regularização. Para as classes I e II, a regularização é por notificação: não há análise técnica prévia e o processamento ocorre em até 30 dias após o protocolo. Isso não dispensa requisito. A empresa continua respondendo pela conformidade e o dossiê técnico fica disponível para fiscalização a qualquer momento.

Para as classes III e IV, a regularização é por registro. Uma equipe multidisciplinar analisa o dossiê antes da decisão, o certificado de boas práticas de fabricação é obrigatório e a validade é de 10 anos, com revalidação. O prazo legal de decisão é de 90 dias, com a contagem suspensa enquanto houver exigência. A empresa tem 120 dias, improrrogáveis, para responder a uma exigência.

CLASSES I E II

Regularização por notificação

Sem análise técnica prévia. A responsabilidade pela conformidade continua com a empresa.

CLASSES III E IV

Regularização por registro

Análise técnica antes da decisão, certificado de BPF e avaliação clínica mais profunda.

PRAZO LEGAL NÃO É PRAZO REAL

O prazo da norma é o limite para a decisão. A fila de análise publicada pela Anvisa mostra o tempo de fato. Considere as duas informações ao ler um cronograma de projeto.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Os caminhos de regularização

Comparando com EUA e União Europeia

JURISDIÇÃO	MENOR RISCO	MAIOR RISCO
Brasil	Notificação (I e II)	Registro (III e IV)
EUA	Isenção ou 510(k)	PMA (Classe III)
União Europeia	Autodeclaração (Classe I)	Organismo notificado

Para a avaliação clínica, a consequência prática é direta. Na regularização por registro, a análise técnica lê a avaliação clínica antes da decisão e pode gerar exigências sobre ela. Na regularização por notificação, a mesma avaliação só será lida numa fiscalização, e então qualquer lacuna já estará com o produto no mercado.

As taxas de cada jurisdição mudam a cada ano fiscal. Sempre confira a tabela vigente na fonte oficial antes de usar um valor.

IDEIA-CHAVE

Regime simplificado não significa exigência menor: significa que ninguém confere antes. A evidência precisa estar pronta do mesmo jeito.

Fonte: RDC 751/2022, art. 10, 11, 13 e 14; Lei 6.360/1976, art. 12; 21 CFR 807; 21 CFR 814.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Os caminhos de regularização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Avaliação clínica e investigação clínica

NA AULA **Parte 2 • Bloco 3 • slides 4 a 12** **Para revisar • Perguntas 4 e 5**

Note a diferença entre avaliar todos os dados clínicos e conduzir um estudo em seres humanos.

Avaliação clínica e investigação clínica são coisas diferentes, e confundir as duas é um dos erros mais comuns em dossiês. A avaliação reúne e analisa todos os dados clínicos; a investigação é uma das fontes desses dados.

A avaliação clínica é um processo contínuo. Ela junta literatura, dados de pós-mercado e resultados de investigações, avalia cada conjunto e conclui se o dispositivo é seguro, tem o desempenho declarado e um benefício-risco aceitável. A investigação clínica é um estudo planejado em seres humanos, conduzido segundo as boas práticas clínicas da ISO 14155:2026.

Três referências que você vai usar

- **Guia Anvisa nº 31/2020, versão 2.** Trata da avaliação clínica de dispositivos médicos. É recomendatório, baseado no IMDRF e centrado na proporcionalidade.
- **MEDDEV 2.7/1 Rev. 4.** Organiza a avaliação em estágios, do escopo ao relatório de avaliação clínica. Foi publicado em 2016, ainda sob as diretivas europeias.
- **Regulamento (UE) 2017/745.** O artigo 61 e o Anexo XIV tornam a avaliação clínica obrigatória para todas as classes e preveem o acompanhamento clínico pós-mercado.

Proporcionalidade: a evidência acompanha o risco

Para a Classe I, documentação técnica e literatura de tecnologia consolidada costumam bastar. Na Classe II, a literatura e o pós-mercado podem sustentar a avaliação, com estudo próprio quando a literatura não cobre a finalidade. Nas classes III e IV, a investigação própria é a regra para inovação, nova indicação ou falta de equivalente.

> **INVESTIGAÇÃO NO BRASIL**
>
> A RDC 837/2023 trata da investigação clínica de dispositivos e cita a ISO 14155 como referência de boas práticas. Quando o estudo é exigido, a empresa solicita a autorização à Anvisa e precisa da aprovação ética antes de iniciar.

Quando o avaliador lê uma avaliação clínica, ele quer ver as três fontes consideradas, mesmo que alguma tenha sido descartada. Uma investigação clínica isolada, sem literatura e sem pós-mercado, deixa perguntas sem resposta. Uma revisão de literatura sem análise de aplicabilidade ao dispositivo também.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Avaliação clínica e investigação clínica

Atenção à edição da norma. A ISO 14155:2026, 4ª edição, publicada em 2026, substituiu a edição de 2020. Ao ler documentos que citam a edição anterior, verifique se a referência foi revisada.

IDEIA-CHAVE

A pergunta do avaliador não é qual o mínimo exigido, e sim qual evidência sustenta cada alegação de segurança e desempenho.

Fonte: ISO 14155:2026; RDC 837/2023; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seção 6; Regulamento (UE) 2017/745, art. 61 e Anexo XIV; Guia Anvisa nº 31/2020.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Avaliação clínica e investigação clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

O dossiê técnico visto por quem avalia

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 13 a 18** Para revisar • Pergunta 6

Acompanhe como cada seção do dossiê se liga a um requisito essencial e à evidência que o comprova.

O dossiê técnico é onde a classificação, as especificações e a evidência clínica se encontram. Quem avalia não lê o dossiê em ordem: segue o fio entre cada requisito e a prova que o sustenta.

Na aula, o dossiê é apresentado em sete grandes seções. Para o seu estudo, o importante é saber o que o avaliador procura em cada uma e como elas conversam entre si.

SEÇÃO	O QUE O AVALIADOR CONFERE
Identificação	Nomes, modelos, classe e a regra aplicada, com o racional
Especificações	Materiais, componentes e parâmetros coerentes com o uso declarado
Projeto e fabricação	Processos sob o sistema da qualidade (ISO 13485 e RDC 665/2022)
Verificação e validação	Ensaios de bancada, software, esterilização e biocompatibilidade
Rotulagem	Rótulo e instruções de uso alinhados à finalidade
Dados clínicos	Avaliação clínica e, quando houver, investigação clínica
Gerenciamento de risco	Arquivo conforme a ISO 14971

A classificação vem antes de tudo

No exemplo fictício usado em aula, um stent coronário com eluição de fármaco cai na Classe IV pela Regra 8 e pela Regra 14. A Anvisa e o organismo notificado conferem a classificação antes de olhar o restante. Se a regra não estiver citada, a revisão já começa com uma exigência.

Evidência não clínica que sustenta a clínica

Processos de fabricação validados, ensaios de desempenho com critérios definidos antes do ensaio e avaliação biológica pela série ISO 10993 formam a base que a avaliação clínica complementa. Quando a bancada já demonstra uma característica, a evidência clínica se concentra no que só o uso em pacientes consegue mostrar.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

O dossiê técnico visto por quem avalia

Na prática da revisão, as perguntas se repetem: a especificação declarada é a mesma que foi ensaiada? O lote ensaiado representa o produto final? O arquivo de risco cita os mesmos perigos que a avaliação clínica discute? Inconsistências entre seções pesam tanto quanto uma seção ausente.

SINAL DE ALERTA

Um requisito essencial aplicável sem indicação da seção do dossiê que o comprova. Na revisão, isso aparece como lacuna, mesmo que a evidência exista em algum lugar do arquivo.

IDEIA-CHAVE

Para o avaliador, o dossiê é uma rede de rastreabilidade: requisito, método de atendimento e prova.

Fonte: RDC 751/2022, Anexo I; RDC 848/2024; RDC 665/2022; ISO 14971:2019; série ISO 10993.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O dossiê técnico visto por quem avalia

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Uso pretendido e mau uso

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 19 a 26** Para revisar • Pergunta 7

Veja como cada termo da finalidade de uso precisa ter evidência no dossiê, e o que acontece quando a frase promete mais do que os dados mostram.

O uso pretendido delimita a avaliação clínica. Toda alegação precisa de evidência, e toda evidência precisa caber no uso declarado. Por isso, o avaliador lê essa frase com lupa.

O modelo do IMDRF organiza a finalidade de uso em elementos que você consegue conferir um a um: a condição clínica, a população, a parte do corpo, a gravidade, quem usa o dispositivo e em que ambiente. Cada elemento abre uma pergunta: há dados para essa condição, nessa população, nesse ambiente?

Uso pretendido e mau uso

Além do uso declarado, o fabricante precisa prever o mau uso razoavelmente previsível: população incorreta, reuso de descartável, técnica inadequada, erro de uso. A IEC 62366-1 trata da engenharia de usabilidade e a ISO 14971 define a ordem de prioridade dos controles: segurança inerente pelo projeto, medidas de proteção e informação de segurança.

O QUE DECLARAR

Elementos do uso

Condição, população, parte do corpo, gravidade, usuário e ambiente.

O QUE PREVER

Mau uso

Erros e usos indevidos que se pode esperar razoavelmente, com os controles correspondentes.

Três armadilhas que o avaliador encontra

- **Frase genérica demais.** "Tratamento de doença cardíaca" não pode ser sustentado por nenhum conjunto de dados. A finalidade precisa dizer qual lesão, em qual vaso, em qual paciente.
- **Alegação além da evidência.** Se o estudo incluiu lesões até um certo tamanho, a finalidade não pode cobrir lesões maiores sem novos dados.
- **Limitações omitidas.** Declarar "todos os pacientes diabéticos" ignora os critérios de exclusão do estudo. A população declarada deve refletir a população estudada.

Na aula, a finalidade de uso é trabalhada em exemplos didáticos, como uma bomba de insulina, uma prótese de quadril e um monitor de pressão arterial. Repare que em cada um a frase final já carrega a classe, a população validada e as exclusões que o estudo impôs.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Uso pretendido e mau uso

TESTE RÁPIDO

Ao ler uma finalidade de uso, sublinhe cada termo e procure no dossiê a evidência correspondente. Termo sem evidência é alegação sem suporte.

IDEIA-CHAVE

A finalidade de uso é o contrato entre o fabricante e o avaliador: o que está escrito ali é o que precisa ser demonstrado.

Fonte: IMDRF, princípios de finalidade de uso; ISO 14971:2019, 7.1; IEC 62366-1; Guia Anvisa nº 31/2020.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Uso pretendido e mau uso

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Harmonização e caso integrador

NA AULA **Parte 2 • Bloco 6 • slides 27 a 33** Para revisar • Pergunta 8

Observe como um mesmo produto segue caminhos diferentes em cada jurisdição, apoiado na mesma evidência publicada.

As jurisdições não são iguais, mas conversam. Saber onde elas se alinham permite reaproveitar evidência com segurança e saber onde é preciso complementar.

Três pontes entre as jurisdições

- **IMDRF.** Fórum de reguladores criado em 2011 como sucessor do GHTF. A Anvisa integra o comitê gestor, ao lado de UE, EUA, Japão, Canadá, Austrália e outros.
- **MDSAP.** Um programa de auditoria única do sistema da qualidade, aceito por Austrália, Brasil, Canadá, Japão e EUA.
- **Requisitos essenciais.** Na UE, os requisitos gerais de segurança e desempenho do Anexo I do MDR, organizados em 23 seções. No Brasil, a RDC 848/2024 trata dos requisitos essenciais de segurança e desempenho.

Para o avaliador, os requisitos essenciais são a espinha do dossiê. Cada requisito aplicável precisa de um método de atendimento e da referência ao documento que o comprova. Em uma válvula cardíaca transcateter, por exemplo, os requisitos de desempenho e benefício-risco remetem aos dados clínicos, os de propriedades biológicas remetem à avaliação biológica e os de rotulagem remetem às instruções de uso e ao cartão do implante.

O caso integrador

O caso da aula acompanha um sistema de monitoramento contínuo de glicose que foi aprovado na União Europeia, depois nos EUA pela via mais rigorosa e, numa versão seguinte, por uma via simplificada, depois que a FDA criou uma categoria própria para esse tipo de produto. Um mesmo estudo de exatidão, publicado em revista revisada por pares, apoiou submissões diferentes.

JURISDIÇÃO

Mesmo produto, caminhos diferentes

Cada regulador escolheu a via de acordo com o seu enquadramento e o momento do produto.

EVIDÊNCIA

Dado publicado sustenta o pedido

Um estudo bem conduzido e publicado pode servir de base comum para várias submissões.

A lição para quem avalia: reaproveitar evidência entre jurisdições é legítimo quando a população, a indicação e o dispositivo estudado são os mesmos do pedido. Se algum desses elementos muda, a evidência precisa de complemento.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Harmonização e caso integrador

ANTES DE CITAR UM PRODUTO

Confira o número de regularização na consulta pública de produtos da Anvisa e os números de processo nas bases oficiais da FDA. Não use números de memória.

IDEIA-CHAVE

Harmonizar não é copiar: é mapear o mesmo conjunto de evidências para os requisitos de cada jurisdição.

Fonte: IMDRF; MDSAP; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I; RDC 848/2024.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Harmonização e caso integrador

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Classe de risco

Nível de risco do dispositivo, de I a IV no Brasil, definido pelas regras de classificação.

Regra de classificação

Critério do anexo de classificação que leva o dispositivo a uma classe. Vale a mais alta entre as aplicáveis.

Notificação

Regime de regularização na Anvisa para as classes I e II, sem análise técnica prévia.

Registro

Regime de regularização na Anvisa para as classes III e IV, com análise técnica antes da decisão.

510(k)

Via da FDA em que o fabricante demonstra equivalência substancial a um dispositivo predicado.

PMA

Aprovação pré-mercado da FDA, via mais rigorosa, em geral para a Classe III.

Avaliação clínica

Processo contínuo que reúne e analisa todos os dados clínicos para concluir sobre segurança, desempenho e benefício-risco.

Investigação clínica

Estudo planejado em seres humanos para avaliar segurança ou desempenho, conduzido segundo a ISO 14155:2026.

DICD

Dossiê de investigação clínica de dispositivo, submetido à Anvisa quando a investigação exige autorização.

Uso pretendido

Declaração do que o dispositivo faz, para qual condição, em qual população, por quem e onde.

Requisitos essenciais

Requisitos de segurança e desempenho que o dispositivo precisa atender; na UE, os GSPR do Anexo I do MDR.

IMDRF

Fórum internacional de reguladores de dispositivos médicos, sucessor do GHTF.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que um erro de classificação compromete toda a avaliação clínica, e não só o regime escolhido? *(Cap. 1)*

2. Dois produtos na mesma classe podem exigir evidências clínicas muito diferentes. O que explica essa diferença? *(Cap. 2)*

3. Se a notificação não tem análise técnica prévia, por que a evidência precisa estar tão pronta quanto na regularização por registro? *(Cap. 3)*

4. Qual a diferença entre avaliação clínica e investigação clínica, e como uma alimenta a outra? *(Cap. 4)*

5. Como a proporcionalidade ao risco muda a pergunta que o avaliador faz sobre a literatura disponível? *(Cap. 4)*

6. Ao revisar um dossiê, o que mostra que um requisito essencial está de fato atendido? *(Cap. 5)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. Uma finalidade de uso promete mais do que o estudo incluiu. Que consequência isso tem na avaliação? *(Cap. 6)*

8. Por que o mesmo estudo publicado pode sustentar submissões diferentes em jurisdições diferentes? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com